

# Gerente Geral

O manual da direção: o painel do dia, os números da clínica, as metas, o marketing, os acessos de cada pessoa e as configurações do sistema.

## PARA QUEM É ESTE MANUAL

Direção e gerência da clínica.

Este aplicativo enxerga **tudo** — inclusive as telas da Recepção, do Consultório e do Financeiro, que têm manuais próprios.

## NESTE MANUAL

Painel da direção

Indicadores e metas

Rentabilidade

Acessos e auditoria

Configurações e backup

---

Programa: **Clínica SemDor — Gerente Geral** (ícone azul com o nome “Gerente” na área de trabalho).

Aqui estão as telas que **só a direção** tem, e as decisões que só ela pode tomar.

# O que você vai encontrar aqui

---

|    |                                         |                                                     |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Antes de começar                        | abrir, entrar e entender a tela                     |
| 2  | Painel da direção                       | o que exige ação hoje                               |
| 3  | Relatórios / BI                         | indicadores, metas, resultado e produção            |
| 4  | Metas                                   | o alvo do mês, e por que ele muda a leitura         |
| 5  | Rentabilidade e custos                  | quanto rende cada convênio                          |
| 6  | Faturamento (TISS)                      | a leitura gerencial das guias                       |
| 7  | Tabela de preço                         | convênios e particular                              |
| 8  | Marketing / Recall                      | campanhas, quem sumiu, de onde vêm                  |
| 9  | Conformidade e acessos                  | auditoria, guarda do prontuário, usuários           |
| 10 | Acessos                                 | quem pode o quê — a tela mais importante da direção |
| 11 | Configurações                           | a clínica, os prazos, backup, termos, e-mail        |
| 12 | Importar pacientes                      | trazer a carteira do sistema antigo                 |
| 13 | Quando algo dá errado · FAQ · Glossário |                                                     |

# Antes de começar

O Gerente Geral é o único aplicativo que carrega **todos** os módulos. Por isso o menu dele é o maior — e por isso ele vem agrupado por assunto, com os grupos que abrem e fecham.

## COMO LER ESTE MANUAL

As imagens são **desenhos das telas** feitos a partir do próprio sistema: os nomes dos botões, das colunas e dos campos são exatamente os que você vai ver no computador. O que muda é o conteúdo.

## ESTE MANUAL NÃO REPETE OS OUTROS

As telas da Recepção (agenda, pacientes, lançamento), do Consultório (prontuário, prescrições) e do Financeiro (caixa, contas, conciliação) aparecem no seu menu e estão explicadas nos **manuals daqueles módulos**. Aqui estão só as telas que **a direção tem e os outros não**.

## 1.1 · A tela por dentro

A imagem mostra a interface do sistema de Gerente Geral da Clínica SemDor. No topo, há uma barra de busca com o texto "Ir para... (Ctrl+F)" e um botão "DS Direção". O menu lateral à esquerda está dividido em seções: "GESTÃO" (com subitem "Painel" selecionado), "PACIENTE", "ATENDIMENTO", "FINANCEIRO" e "INTELIGÊNCIA". Abaixo de "Painel", há uma lista de itens: "Agenda", "Profissionais e salas", "Relatórios / BI", "Rentabilidade e custos", "Marketing / Recall", "Conformidade e acessos" e "Configurações". O conteúdo principal da tela é o "Painel da direção", que apresenta quatro cartões de métricas: "FATURADO NO MÊS" (R\$ 84.2k, +12% vs. mês anterior), "SESSÕES" (412, +6%), "OCUPAÇÃO" (68%, -3%) e "RESULTADO" (R\$ 21.7k, +9%). Abaixo desses cartões, há uma seção "O que exige ação hoje" com quatro itens: "Urgente" (7 guias com prazo de decisão vencido), "Atenção" (3 glosas com prazo de recurso terminando), "Atenção" (12 sessões sem evolução escrita) e "Aviso" (R\$ 4.310 de pacientes devendo). Cada item possui um botão "Abrir" para mais detalhes.

**O painel da direção.** Cada alerta **leva** à tela onde ele se resolve — o botão fica apagado quando aquele destino não existe para o seu acesso.

## 1.2 · Os grupos do menu

| GRUPO               | O QUE TEM DENTRO                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GESTÃO</b>       | O dia da clínica: painel, agenda, profissionais e salas, ajuda.                           |
| <b>PACIENTE</b>     | A pessoa: cadastro, documentos, pacotes, preços, retorno, importação.                     |
| <b>ATENDIMENTO</b>  | O ato de atender: lançar e marcar, prontuário, prescrições, enfermagem.                   |
| <b>FINANCEIRO</b>   | O dinheiro: caixa, contas, recebimentos, estoque, repasses, faturamento, tabela de preço. |
| <b>INTELIGÊNCIA</b> | A leitura do negócio: BI, metas, rentabilidade, marketing, conformidade, configurações.   |

Clicar no nome do grupo abre e fecha aquele grupo. Navegar para uma tela abre o grupo dela e fecha os outros — assim a lista não cresce sem parar.

**Ctrl + B** recolhe o menu para só os ícones (e devolve); **Ctrl + F** abre a busca de telas, que também procura dentro das abas e diz o caminho (“Fechamento de caixa — em Caixa”).

# Painel da direção

A tela que abre o aplicativo. Ela não calcula nada por conta própria: cada número vem do serviço que é dono dele, para não haver duas respostas para a mesma pergunta.

Menu **GESTÃO** > **Painel** > aba **Direção**

## 2.1 · Os blocos

| BLOCO                 | O QUE RESPONDE                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metas do mês          | Como o mês está indo <b>contra o alvo</b> que a direção definiu. Sem meta cadastrada, ele compara com o mês anterior — que responde “melhorou?”, nunca “chegamos onde a gente disse que ia chegar?”. |
| O que exige ação hoje | A lista de alertas, cada um com um botão que <b>leva</b> à tela onde ele se resolve.                                                                                                                 |

### Os alertas que aparecem

| ALERTA                                 | SIGNIFICA                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guias com prazo de decisão vencido     | Guias pendentes há mais dias do que o prazo configurado. Se ninguém decidir, o faturamento trava numa janela obrigatória. |
| Glosas com prazo de recurso terminando | Passado o prazo, não é mais pendência — é prejuízo consumado.                                                             |
| Prontuário em aberto                   | Sessões que aconteceram e não têm evolução escrita.                                                                       |
| Guia faturada sem prontuário           | Mais grave que o anterior: é cobrança sem o documento que a sustenta.                                                     |
| Infusão aguardando                     | Folhas de infusão com item por executar.                                                                                  |
| Infusão sem assinatura                 | Folhas encerradas esperando a assinatura da enfermagem.                                                                   |
| Contas a pagar / pacientes devendo     | São <b>dois</b> alertas separados: um se resolve pagando, o outro cobrando. Somá-los daria um número sem significado.     |

**CADA BLOCO FALHA SOZINHO**

Se uma leitura não puder ser feita, aquele bloco mostra “**não foi possível verificar**” e o resto continua. Um painel dizendo “nada vencido” por causa de uma consulta quebrada seria pior do que um painel que avisa.

#### A COMPARAÇÃO É COM O MESMO TRECHO DO MÊS ANTERIOR

No dia 5, ele compara cinco dias com cinco dias — não cinco com trinta. Senão todo começo de mês apontaria queda de 80%, e qualquer pessoa aprenderia a ignorar a seta.

As outras duas abas do **Painel** são o painel da **Recepção** (como está o balcão agora) e o **Meu dia** do profissional — explicados nos manuais daqueles módulos.

# Relatórios / BI

Cinco abas com a leitura do desempenho da clínica.

Menu **INTELIGÊNCIA** > Relatórios / BI

## 3.1 · Indicadores

| COLUNA                    | O QUE MEDE                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atendidos                 | Sessões concluídas por profissional no período.                                                                                           |
| Faltas / No-show (%)      | Quantos não vieram. <b>Cancelamento avisado não conta como falta</b> — quem desmarcou deu chance de reocupar.                             |
| Horas                     | Tempo de agenda ocupado.                                                                                                                  |
| Evoluções / Prontuário    | Quantas sessões têm registro escrito, e o percentual. “—” <b>quando não houve sessão</b> — não se acusa de negligência quem tirou férias. |
| Queda média da dor        | A diferença média entre a EVA antes e depois.                                                                                             |
| Ocupação por profissional | Medida contra os dias em que ele <b>teve agenda</b> × a jornada configurada — e não contra um calendário inventado.                       |

**Exportar** gera a planilha. **Métrica sem base de cálculo sai como “—” também na planilha**, para o Excel não calcular média sobre um número que não existe.

## 3.2 · As outras abas

- **Metas** — o capítulo 4.
- **Resultado do mês** — a demonstração do período (manual do Financeiro, capítulo 15).
- **Produção** — volume de sessões e receita em 6 ou 12 meses.
- **Meus números** — a tela do profissional (manual do Consultório).

# Metas

Sem meta, o painel só sabe comparar com o mês anterior — e variação responde “melhorou?”, nunca “**chegamos onde a gente disse que ia chegar?**”. Um mês 10% melhor que um mês ruim aparece como vitória.

Menu **INTELIGÊNCIA** › **Relatórios** / **BI** › aba **Metas**

- 1 Escolha o mês (◀▶) e clique em **Nova meta**.
- 2 **Indicador** (faturamento, sessões, ocupação...), **de quem** (a clínica ou um profissional) e o **alvo**.
- 3 Salve. A tela passa a mostrar **Realizado** e **Situação** ao lado do alvo.

| REGRA                                       | POR QUÊ                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uma meta por mês, por indicador, por pessoa | Duas metas para a mesma pergunta dariam duas réguas, e a tela escolheria uma sem dizer qual.                                      |
| Sem meta ≠ meta zero                        | Sem linha é “não decidimos”; zero é “decidimos que é zero”. Inventar zero faria todo mês não planejado aparecer como alvo batido. |
| Reajustar agosto não reescreve julho        | Cada mês é uma linha própria.                                                                                                     |
| Não se projeta mês com menos de 5 dias      | Projetar no dia 2 multiplica ruído por quinze.                                                                                    |
| Ocupação não se projeta por regra de três   | Ela já é uma média; multiplicá-la pelos dias que faltam daria 300%.                                                               |

**VER O NÚMERO E DECIDIR SOBRE ELE SÃO ACESSOS DIFERENTES**

Dar acesso ao BI não dá o poder de apagar as metas do ano. São dois bits separados, e a direção pode conceder um sem o outro.

# Rentabilidade e custos

Menu INTELIGÊNCIA › Rentabilidade e custos

## 5.1 · Por convênio

A leitura que decide negociação de tabela.

| COLUNA   | O QUE É                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guias    | Quantas guias daquela operadora no período.                                                                                                                                                                |
| Bruto    | O valor cheio.                                                                                                                                                                                             |
| Retido   | O imposto que a operadora reteve na fonte.                                                                                                                                                                 |
| Líquido  | O que sobrou.                                                                                                                                                                                              |
| Por guia | <b>A leitura central.</b> É o único número comparável entre operadoras com valores e volumes diferentes — a “menos rentável” é apurada por guia, e não pelo total, que apontaria sempre a de menor volume. |
| Prazo    | O tempo médio até o pagamento. <b>Só conta o que já foi pago</b> — incluir o previsto mediria uma promessa, e quem atrasa teria o melhor número.                                                           |

**O AGRUPAMENTO É POR OPERADORA, NÃO POR FAMÍLIA DE REGRA**

Duas operadoras podem compartilhar a mesma regra de faturamento e mesmo assim ser negócios diferentes. Somá-las daria “Porto Saúde: 143 guias” quando são duas operadoras juntas — o número que a direção usa para negociar.

## 5.2 · Custo de taxas e impostos

Quanto a clínica paga de maquininha e de imposto, mês a mês. A leitura que só existe aqui é a **taxa efetiva contra a de tabela**: a tabela diz 3,1%, e se a clínica parcela mais do que imagina o efetivo é 3,9%. É essa diferença que dá argumento na renegociação.

A tabela vem como **faixa** (menor e maior taxa vigente), porque uma adquirente tem várias taxas e um número só teria de escolher uma modalidade.

# Faturamento (TISS)

A leitura **gerencial** do faturamento, em cinco abas. Quem opera as guias no dia a dia é o aplicativo de Faturamento (manual próprio); aqui a direção acompanha e, quando precisa, age.

Menu **FINANCEIRO** › **Faturamento (TISS)**

| ABA               | O QUE MOSTRA                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visão geral       | Por convênio: guias geradas, baixadas, pendentes, <b>taxa de baixa</b> , glosa e tempo médio. Mais a evolução da taxa de baixa e as pendências por faixa de atraso.                                                                                       |
| Pendências        | As guias esperando baixa, com filtros por convênio, urgência e paciente. Dá para <b>Dar baixa</b> e <b>Anotar</b> aqui mesmo.                                                                                                                             |
| Glosas            | As guias recusadas, com prazo de recurso. <b>Reapresentar</b> registra o recurso; <b>Recuperada</b> registra que o convênio pagou.                                                                                                                        |
| Não conformidades | As guias que alguém decidiu <b>não faturar</b> , com a justificativa escrita. <b>Reabrir</b> devolve a guia à fila de pendências.                                                                                                                         |
| Lotes             | Os lotes TISS gerados, enviados e com retorno. Aqui é <b>só leitura</b> : gerar lote é do aplicativo de Faturamento, porque o número do lote é uma sequência e dois programas gerando ao mesmo tempo produziriam lotes duplicados que a operadora recusa. |

**Fechamento em PDF** gera o relatório do período para arquivar ou mandar ao contador.

**DAR BAIXA DAQUI É O MESMO ATO DO FATURAMENTO**

Inclusive a conferência do **número da guia**: cada convênio tem um formato (a Unimed só numera com dígitos, por exemplo), e o sistema critica enquanto você digita — para o “O” no lugar do zero não passar e só aparecer no retorno da operadora, semanas depois.

# Tabela de preço

Menu **FINANCEIRO** › Tabela de preço

## 7.1 · Convênios

Quanto cada convênio paga por cada tipo de guia. É o que faz a **Conciliação** do Financeiro abrir já com o valor preenchido e a procedência escrita ao lado.

- 1 **Novo preço.**
- 2 Escolha o **convênio**, o tipo de guia e, se o preço muda por especialidade, a **especialidade**.
- 3 Informe o **valor** e a **vigência**.
- 4 Salve.

- A regra **mais específica ganha** — especialidade vence o genérico.
- Reajuste é **linha nova**: a guia de março segue valendo o preço de março.
- **Sem preço cadastrado o campo fica vazio**, e não zero — chutar um valor de mercado daria receita errada com aparência de exata.
- **Só o que vale hoje** esconde as linhas fora de vigência.

## 7.2 · Particular

A mesma ideia para quem não tem convênio, chaveada pelo que a clínica **faz**: **modalidade** (obrigatória) + **especialidade atendida** (opcional). Está explicada no manual da Recepção, capítulo 10 — a direção e o balcão cadastram na mesma tela.

# Marketing / Recall

Menu **INTELIGÊNCIA** > Marketing / Recall

## 8.1 · Campanhas

Três tipos de contato, todos com o mesmo registro:

| RODADA                        | O QUE FAZ                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Confirmações de amanhã</b> | Monta a lista de quem tem horário amanhã, para confirmar. <b>Não exige autorização de marketing</b> — confirmar a própria sessão é assunto do atendimento. |
| <b>NPS de ontem</b>           | Pergunta a nota a quem foi atendido ontem. <b>Exige autorização.</b>                                                                                       |
| <b>Recall do mês</b>          | Convida de volta quem não vem há um tempo. <b>Exige autorização.</b>                                                                                       |

- 1 Clique no botão da rodada que quer gerar.
- 2 A lista aparece com **paciente, telefone, campanha e situação**.
- 3 **WhatsApp** abre a conversa com a mensagem pronta — um clique por pessoa, porque o número é o WhatsApp da clínica.
- 4 **Respondeu / Nota** registram o retorno; **Dispensar** tira o contato da fila.

### QUEM NÃO AUTORIZOU APARECE CONTADO, COM O MOTIVO

Em vez de sumir da lista. Some da lista, some da cabeça — e “12 pacientes” que eram 30 faz a clínica concluir que quase ninguém está sumindo. **Dispensar** é a permissão que faz um contato sumir da fila **sem ninguém ter falado com o paciente**, e por isso ela é da direção.

## 8.2 · Quem parou de vir

A lista caso a caso, para a direção decidir quem vale um telefonema de verdade — o paciente de tratamento longo que some vale dez recalls disparados no vazio.

- **Quem tem sessão futura marcada não aparece**, por mais tempo que faça desde a última: ele já voltou, só ainda não veio.
- **Só quem era frequente e Só com pacote em aberto** estreitam a lista. O segundo é o caso que a clínica deve tanto ao paciente quanto a si: ele pagou sessões que não usou.
- **Chamar de volta** abre o WhatsApp; **Exportar CSV** gera a planilha.

### 8.3 · De onde vêm os pacientes

Responde a pergunta que justifica a pergunta do balcão (“como conheceu a clínica?”):

- **Origem × na base × % da base × estrearam no período.**
- **Quem mais indica (10 maiores)** — as pessoas que trazem pacientes.
- **“Estreou no período”** = o **primeiro atendimento** daquela pessoa caiu no período. Cadastro sem atendimento é intenção; atendimento é a clínica trabalhando.
- **“Não perguntado”** aparece como linha normal, ordenada junto das outras. Quando ela encabeça a tabela, o achado do relatório é que o balcão parou de perguntar.

### 8.4 · Retorno de pacientes

A tela de telefonar, que a Recepção também tem — está no manual dela, capítulo 11.

# Conformidade e acessos

Três abas que respondem às perguntas de uma auditoria: **quem fez**, **quem leu** e **o que a clínica guarda**.

Menu **INTELIGÊNCIA** › **Conformidade e acessos**

## 9.1 · Auditoria

A trilha de tudo o que foi feito no sistema: quem, quando e o quê.

- 1 Escolha o período em **De** e **Até** (o dia final entra inteiro).
- 2 Filtre por **ação** (basta o começo: “Conta” acha ContaCriada e ContaReagendada), **operador**, **paciente** ou um trecho **no detalhe**.
- 3 Marque **Só quem ABRIU o prontuário** para investigar acesso indevido de **leitura** — que é o caso clássico numa clínica, e o que a permissão sozinha não cobre.
- 4 **Consultar**. **Exportar** gera a planilha.

### A TRILHA É SOMENTE LEITURA

Não há como editar nem apagar um registro de auditoria — nem aqui, nem em lugar nenhum. Registro de auditoria que se pode alterar não é auditoria, é rascunho.

### QUANDO ELE AVISA QUE BATEU NO LIMITE

A consulta tem um teto de linhas. Se ele for atingido, a tela **diz** — “300 eventos” que na verdade são 300 de 4.000 faria a direção concluir que o período teve pouca movimentação.

## 9.2 · Guarda do prontuário

A tela que responde ao auditor “**o que vocês guardam, e por quanto tempo**”.

| BLOCO                    | O QUE MOSTRA                                                                                                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A clínica inteira</b> | Prazo legal, quantos pacientes, quantos têm prontuário, quantos registros guardados, quantos já cumpriram o prazo e qual é o registro mais antigo. |
| <b>Um paciente</b>       | Escolha a pessoa e clique em <b>Calcular a guarda</b> : até quando aquele prontuário precisa ser guardado.                                         |

| BLOCO                      | O QUE MOSTRA                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Quem abriu este prontuário | A trilha de leitura daquele paciente — quem abriu, quando e por qual porta. |
| Exportar o prontuário      | De uma pessoa, ou da clínica inteira.                                       |

#### O PRAZO CONTA DO ÚLTIMO REGISTRO, E O SISTEMA NÃO ELIMINA NADA

São **20 anos** a partir do último registro de qualquer natureza, e o prazo é legal — não é configurável, justamente para ninguém baixá-lo sem perceber. Vencido o prazo, o prontuário fica **elegível**; a decisão de eliminar é da clínica, com a comissão prevista em lei. Eliminar sozinho seria ler um **piso** de guarda como agendamento de destruição.

## 9.3 · Acessos

É o capítulo 10 — a tela mais importante da direção.

# Acessos — quem pode o quê

Cada pessoa entra com o próprio usuário, e o que ela alcança é decidido aqui. **Item que a pessoa não pode usar simplesmente não aparece no menu dela.**

Menu **INTELIGÊNCIA** › **Conformidade e acessos** › aba **Acessos**

## 10.1 · Criar um usuário

- 1 Novo usuário.
- 2 Nome, login (sem espaços) e uma **senha provisória**.
- 3 **Perfil**: Recepção, Profissional, Enfermagem, Financeiro, Faturista ou Gerente. O perfil é só o **ponto de partida** das permissões.
- 4 **Profissional**: se a pessoa atende, ligue o usuário ao cadastro dela. **É essa ligação** que faz a agenda ser a dela, o conselho (CRM/COREN) ser copiado nos registros e o CPF do certificado digital ser conferido na assinatura.
- 5 Salve. Na primeira entrada, o sistema pede que ela troque a senha.

## 10.2 · Ajustar permissões

Dentro do usuário, as permissões vêm **agrupadas por assunto**, com a **consequência escrita ao lado de cada caixinha** e a **procedência** de cada uma: padrão da função, liberada à mão ou tirada à mão.

- **Marcar** uma caixinha libera aquela função só para aquela pessoa.
- **Desmarcar** tira. O que foi tirado à mão **vence** o padrão do perfil.
- Corrigir o **padrão de um perfil** alcança quem já está cadastrado — o cálculo é *padrão + liberadas – tiradas*, feito toda vez que a pessoa entra.

## 10.3 · Os cortes que valem a pena entender

| SEPARAÇÃO          | POR QUÊ                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha × Prontuário | <b>Ver ficha</b> é contato (telefone, convênio). <b>Ver prontuário</b> é dado de saúde. É o corte da LGPD, e é o que impede a recepção de ler a evolução de todo mundo para marcar um horário. |
| Baixar × Estornar  | Errar a baixa é acidente; estornar apaga o trabalho de outra pessoa. Por isso o faturista baixa e não estorna.                                                                                 |

| SEPARAÇÃO                              | POR QUÊ                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marcar agenda × Mover a fila</b>    | O profissional move a fila (chegada, chamada, entrada) <b>sem</b> ganhar a agenda do balcão.                                                                           |
| <b>Ver indicadores × Definir metas</b> | O realizado é fato; a meta é a decisão da direção sobre o fato.                                                                                                        |
| <b>Não conformidade</b>                | É a única permissão que faz uma pendência <b>sumir do painel sem a guia ter sido faturada</b> — quem a tem pode zerar o alarme sobre o próprio trabalho que ele cobra. |

#### TROCAR DE USUÁRIO REABRE O APLICATIVO

É de propósito: as telas leem a permissão quando são construídas, e metade delas já está aberta. Permissão que **parece** aplicada e não está é pior do que permissão nenhuma.

#### REDEFINIR SENHA

Gera uma provisória, que a pessoa troca ao entrar. A direção **não vê** a senha de ninguém — e entregar a senha nova pronta trocaria um segredo comprometido por um que já nasce compartilhado.

#### O SISTEMA NÃO DEIXA A CLÍNICA FICAR SEM NINGUÉM QUE GERENCIE ACESSOS

Ele recusa excluir ou rebaixar o último usuário com essa permissão. E se a base ainda não tiver usuário nenhum, o primeiro acesso cria um Gerente — em vez de trancar todo mundo do lado de fora.

# Configurações

Sete blocos. Cada um tem o seu próprio botão de **Salvar** — salvar um não mexe nos outros.

Menu **INTELIGÊNCIA** > **Configurações**

## 11.1 · A clínica

Razão social, nome fantasia, CNPJ, CNES, endereço, telefone, e-mail, cidade e **chave Pix**. É o que sai impresso no cabeçalho de todas as folhas que a clínica entrega.

## 11.2 · Operação e marketing

| CAMPO                    | O QUE MUDA                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jornada diária (minutos) | A base da <b>ocupação</b> . Sem ela, a ocupação seria calculada contra dias úteis inventados.                                                                |
| Recall: dias sem vir     | A partir de quantos dias o paciente entra na lista de recall.                                                                                                |
| Faturamento na marcação  | Liga a opção de <b>a guia nascer já quando o horário é marcado</b> , e não só quando o atendimento é lançado. Veja o aviso abaixo.                           |
| Escrever termos...       | Cadastra os termos que o paciente assina (consentimento, jejum) e diz qual procedimento exige cada um. Há um botão que cria <b>os termos do BSV</b> prontos. |
| Campos do prontuário...  | Cria campos próprios da clínica na folha da sessão (“nº de agulhas”, “aparelho”). Cada campo diz <b>em que modalidade</b> aparece.                           |

**ANTES DE LIGAR “A GUIA NASCE NA MARCAÇÃO”**

**Atualize os cinco aplicativos primeiro.** Um programa desatualizado não entende os registros que o novo cria, e a tela dele pode parar de abrir. A própria tela avisa isso ao lado da caixinha.

## 11.3 · Regras de faturamento (os prazos)

| PRAZO                     | O QUE ELE CONTROLA                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alerta de consulta (dias) | Com quantos dias de antecedência o sistema avisa que a consulta do convênio vai vencer. |

| PRAZO                                       | O QUE ELE CONTROLA                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recurso de glosa (dias)                     | O prazo para recorrer de uma glosa. É ele que o painel vigia.                                                                 |
| Prazo de decisão (dias)                     | Quantos dias uma guia pode ficar pendente antes de o sistema <b>travar</b> o faturamento numa janela obrigatória. Padrão: 10. |
| Consultas a renovar / Carteirinhas a vencer | Duas caixinhas que estendem a rodada obrigatória a esses dois assuntos.                                                       |

## 11.4 · Backup da clínica

- 1 **Escolher pasta...** — onde as cópias serão guardadas.
- 2 **Copiar a cada (dias) e Cópias a guardar** — a rotação. Guardar só a última é o erro clássico: a corrupção que ninguém viu na sexta é copiada por cima da única cópia boa no sábado.
- 3 **Salvar política.** A partir daí a cópia acontece na **abertura do Gerente**, quando o prazo vence.
- 4 **Copiar agora** força uma cópia; **Conferir um backup** verifica um arquivo já gravado.

### GUARDE A CÓPIA FORA DA MÁQUINA

O sistema não tem como saber se a pasta escolhida está num pen drive, num HD externo ou na nuvem — e por isso ele **não promete** que o backup está seguro. Escolha uma pasta que seja sincronizada para fora do computador, e confira de vez em quando.

## 11.5 · Lembretes por e-mail

Servidor SMTP, porta, usuário, senha, remetente e nome do remetente. Com isso configurado, o sistema manda o lembrete da sessão por e-mail na abertura do dia — e quem já foi avisado pelo WhatsApp **não** recebe e-mail. **Enviar arquivo de teste** confere se está funcionando antes de valer para os pacientes.

Sem servidor configurado, **nada muda**: o balcão continua confirmando por WhatsApp, um clique por pessoa, exatamente como antes.

## 11.6 · Publicação de documentos assinados

Onde ficam hospedados os documentos assinados que o paciente leva com QR code (para a farmácia conferir). Campos: domínio da clínica, dias no ar e os dados do armazenamento. **Enviar arquivo de teste** grava um PDF de exemplo e devolve o endereço para você abrir no navegador — é o teste que prova que o farmacêutico vai conseguir abrir.

## 11.7 · Tela do paciente

Escolhe qual **monitor** é o do paciente, quando a clínica tem um monitor com toque para colher assinatura. Há um botão **Testar**: as telas se chamam “DISPLAY1” e “DISPLAY2” e ninguém sabe qual é qual pelo nome — sem testar, o primeiro a descobrir que abriu no monitor errado seria o paciente.

# Importar pacientes

Traz a carteira de pacientes (e o prontuário) do sistema antigo. Funciona em **dois tempos**: primeiro ele mostra o que **vai** acontecer, sem gravar nada; depois você manda gravar.

Menu **PACIENTE** > Importar pacientes

- 1 • **O arquivo.** Escolha o pacote (ZIP) do sistema antigo, ou um CSV de pacientes, ou o ZIP de arquivos (receitas, laudos).
- 2 • **O que cada coluna significa.** O sistema **sugere** a correspondência entre as colunas do arquivo e os campos daqui. **Confira uma por uma** — nomes de coluna enganam (“operadora” pode ser a do celular, não o convênio).
- 3 • Aponte cada **convênio do arquivo** para um convênio cadastrado aqui. O que você não apontar entra como “**A definir**”, e o sistema vai perguntar no balcão quando aquele paciente aparecer.
- 4 • **Gerar a prévia.**
- 5 • **3 • O que vai acontecer.** Linha por linha: qual ficha será **criada**, qual será **completada** e qual será **ignorada** — com o motivo.
- 6 • Só então mande executar.

## IMPORTAR DUAS VEZES NÃO DUPLICA

Cada ficha guarda a chave do sistema de origem. Quem já existe é **completado**, nunca sobrescrito: o convênio que a clínica já ajustou aqui permanece. E duplicatas **dentro do próprio arquivo** entram fundidas numa ficha só.

## A ORDEM IMPORTA PARA O ZIP DE ARQUIVOS

Importe primeiro o pacote de **pacientes**, depois o ZIP de **arquivos** — os arquivos são ligados às fichas pelo id do sistema antigo. Quando o arquivo só traz o nome, ele é ligado apenas se o nome for **único**; homônimos ficam de fora **com o motivo escrito**, em vez de irem para a ficha errada.

## “FECHOU” NÃO QUER DIZER “TUDO ENTROU”

Quer dizer que **o que não entrou está listado, com a razão**. Leia a lista do que ficou de fora antes de dar a importação por concluída.

## Quando algo dá errado · FAQ · Glossário

### 13.1 · Quando algo dá errado

| O QUE APARECE                                         | O QUE FAZER                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Não foi possível verificar” num bloco do painel      | Aquela leitura falhou. <b>Não é “nada pendente”</b> . Use <b>Atualizar</b> ; se insistir, é problema de conexão ou defeito.                                             |
| Uma pessoa diz que “sumiu um menu”                    | É permissão. Abra <b>Acessos</b> , o usuário dela, e confira a caixinha correspondente.                                                                                 |
| A agenda de um profissional aparece vazia no app dele | O usuário dele não está ligado ao cadastro de profissional. Corrija em <b>Acessos</b> .                                                                                 |
| Um número não bate com outra tela                     | Confira se as duas usam o mesmo período e o mesmo recorte. Cada número vem do serviço dono dele — as telas não recalculam por conta própria.                            |
| Um erro em inglês                                     | Falha técnica. Anote a hora e o que estava sendo feito. O detalhe fica em <i>erros-ano-mês.txt</i> , na pasta “logs” ao lado do programa — é o que o suporte vai pedir. |

### 13.2 · Perguntas frequentes

#### Como libero uma função só para uma pessoa?

**Acessos** › o usuário › marque a caixinha. Não é preciso mudar o perfil dela nem mexer no das colegas.

#### A recepcionista precisa digitar a evolução que o profissional dita.

Conceda **Escrever no prontuário** àquela pessoa, em **Acessos**. Foi exatamente para isso que a permissão é granular.

#### Como sei quem abriu o prontuário de um paciente?

**Conformidade e acessos** › **Guarda do prontuário**, escolha o paciente e veja “**Quem abriu este prontuário**”. Ou **Auditoria** com a marca “**Só quem ABRIU o prontuário**”.

## Um paciente pediu para excluir os dados dele.

Prontuário não se apaga (a lei manda guardar 20 anos). O caminho é a **anonimização**, na ficha do paciente, aba LGPD: nome, documento, telefone e foto saem; o histórico fica sem dono identificável. A tela avisa isso **antes** de fazer.

## Quero mudar o prazo em que uma guia vira “urgente”.

Configurações › Regras de faturamento › Prazo de decisão (dias).

## Onde vejo se o backup está sendo feito?

Configurações › Backup da clínica. Ele roda na abertura deste aplicativo, quando o prazo vence. Se ninguém abrir o Gerente, o backup não acontece.

## Posso gerar o lote TISS aqui?

Não — só no aplicativo de Faturamento. O número do lote é uma sequência, e dois programas gerando ao mesmo tempo produziram lotes duplicados que a operadora recusa semanas depois.

## 13.3 · Glossário

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicador</b>              | Um número que mede a clínica (sessões, ocupação, faltas, margem).                                     |
| <b>Meta</b>                   | O alvo definido pela direção para um indicador, num mês.                                              |
| <b>Teto de gasto</b>          | O limite de despesa de uma categoria no mês.                                                          |
| <b>Ocupação</b>               | Quanto da agenda foi usado, contra os dias em que o profissional teve agenda × a jornada configurada. |
| <b>No-show</b>                | Faltas sem aviso, em percentual.                                                                      |
| <b>Rentabilidade por guia</b> | Quanto sobra por guia de cada convênio — o número comparável entre operadoras.                        |
| <b>Taxa de baixa</b>          | Quantas das guias geradas foram efetivadas no convênio.                                               |
| <b>Glosa</b>                  | Recusa de pagamento pelo convênio, com prazo para recurso.                                            |
| <b>NC (não conformidade)</b>  | A decisão registrada de não faturar uma guia, com justificativa.                                      |
| <b>Lote TISS</b>              | O pacote de guias enviado ao convênio no padrão da ANS.                                               |
| <b>Recall</b>                 | Chamar de volta quem parou de vir. Exige autorização de contato.                                      |
| <b>NPS</b>                    | A nota que o paciente dá à clínica depois do atendimento.                                             |

|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoria</b>    | A trilha do que foi feito no sistema: quem, quando e o quê. Somente leitura.                                                |
| <b>Guarda</b>       | O prazo legal de 20 anos em que o prontuário precisa ser conservado.                                                        |
| <b>Anonimização</b> | Apagar a identificação do paciente mantendo o histórico. É o que a LGPD permite quando o prontuário não pode ser destruído. |
| <b>Perfil</b>       | O ponto de partida das permissões de um cargo. As permissões individuais vencem o perfil.                                   |

**Este manual descreve as telas exclusivas do Gerente Geral.** As telas que ele compartilha com os outros aplicativos estão nos manuais da **Recepção**, do **Consultório**, do **Financeiro** e do **Faturamento**.